

TẬP ĐOÀN Y TẾ VIỆT - NGA

QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH
(Người bệnh có chỉ định tiêm nội nhãn)

Số: 01./QTKB/TĐYTVN

Ngày ban hành: 10../10/2025

Lần ban hành: 01

Trách nhiệm	Biên soạn thảo	Người phê duyệt
Chức vụ Họ tên	Trần Thị Thảo Nguyên	Phó tổng giám đốc BS. Nguyễn Thị Bích Thủy
Ký tên		 

Lưu hành nội bộ



QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH (Người bệnh có chỉ định tiêm nội nhãn)

Mã số: ..01...
QTKB/TĐYTVN
Ngày ban hành:
12/10/2025
Lần ban hành: 01

1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của tài liệu hướng dẫn quy trình này
2. Nội dung trong quy trình này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của lãnh đạo tập đoàn
3. Mỗi cơ sở được phát 01 bản (có đóng dấu của người phê duyệt). Các cơ sở khi có nhu cầu thêm, đề nghị liên hệ với phòng KHTH – QLCL (Hà Nội) để có bản đóng dấu của người phê duyệt.

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ✓ vào ô bên cạnh)

☒	Ban lãnh đạo tập đoàn		
☒	Giám đốc các bệnh viện		

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (Tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

I. MỤC ĐÍCH

- Xác định trình tự, nội dung, quy trình tiếp nhận khám mắt tại Bệnh viện
- Xác định người chịu trách nhiệm thực hiện quy trình
- Thống nhất quy trình tiếp nhận và quản lý người bệnh khám và có chỉ định tiêm nội nhãn.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng đối với tất cả các trường hợp người bệnh khám và điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh của Tập đoàn Y tế Việt – Nga.

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Quyết định 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 4 năm 2013 về việc ban hành hướng dẫn quy trình khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện;
- Quy chế bệnh viện 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 09 năm 1997;
- Quyết định số 3906/QĐ-BYT ngày 12/10/2012 về việc ban hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nhãn khoa;
- Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 quy định chi tiết một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh;
- Quyết định số 3618/QĐ-BHXH ngày 12/12/2022 về quy trình giám định BHYT
- Quyết định số 3176/QĐ-BYT ngày 29 tháng 10 năm 2024 về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 4750/ QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của bộ trưởng bộ y tế sửa đổi, bổ sung quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan

IV. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

BN	: Bệnh nhân	KHTH	: Kế hoạch tổng hợp
NB	: Người bệnh	QLCL	: Quản lý chất lượng
BS	: Bác sĩ	BV	: Bệnh viện
ĐD	: Điều dưỡng	QĐ	: Quyết định
KTV	: Kỹ thuật viên	BYT	: Bộ Y tế
TKX	: Tật khúc xạ	CSKH	: Chăm sóc khách hàng
CLS	: Cận lâm sàng		

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH

Các bước tiếp nhận và quản lý người bệnh khám mắt tại bệnh viện

Trình tự	Người thực hiện	Người phối hợp	Chi tiết công việc	Ghi chú
Bước 1: Đăng ký thông tin	Người bệnh / người nhà NB		Tại kiosk thông tin: - Tiếp nhận thông tin bằng cách quét mã QR trên ứng dụng VNeID/ CCCD hoặc có thẻ nhập trực tiếp thông tin người bệnh tại kiosk 1. Lựa chọn hình thức khám: - BHYT - Dịch vụ 2. Nhận STT <i>Đối với BN đã thực hiện đăng ký online qua app/ web bỏ qua bước này</i>	Cơ sở HCM có thêm hình thức khám theo yêu cầu (VIP)
Bước 2: Đăng ký khám bệnh	Lễ tân	Marketing/CS KH	- Tiếp nhận NB theo số TT - Khai thác sơ bộ lý do - Chọn gói khám - Chọn phòng khám / BS khám - In phiếu khám (<i>trong phiếu có hướng dẫn đến phòng khúc xạ/phòng chức năng + phòng khám và thứ tự cần thực hiện trước sau</i>) Đối với BN đăng ký online đã được Marketing tư vấn và tích gói khám -> lễ tân chỉ thực hiện in phiếu khám	CS HCM: Phát sinh STT theo đầu mã gói khám TQ – chuyên sâu – tái khám
Bước 3: Thu phí	Thu ngân		Thu phí - NB đóng phí khám bệnh theo bảng giá quy định tại Bệnh viện - Đầy cỗ check-in (đầy tự động) – đối với NB đăng ký khám BHYT <i>NB có thể đóng phí bằng QR code động -> đưa bill giao dịch thành công cho thu ngân -> thu ngân xác nhận đã thanh toán -> BP. lễ tân đưa hồ sơ khám cho NB</i>	- CS HCM: Thu chênh đối với toàn bộ NB đăng ký khám BHYT ở các bước có thu phí - CS HL, HP: Thu toàn bộ chi phí, kết thúc khám sẽ hoàn lại tiền cho bệnh nhân
Bước 4: Đo thị lực, khúc xạ và nhãn áp	KTV Khúc xạ/ điều dưỡng Phòng khúc xạ/ chức năng		NB cầm phiếu khám (<i>trong đó có hướng dẫn đi đến phòng khúc xạ/ phòng chức năng</i>), thực hiện check-in, nhận STT, chờ trước cửa phòng, theo dõi STT hiển thị trên màn hình, đến lượt vào phòng, thực hiện đo 1. Đo khúc xạ tự động 2. Đo thị lực:	* CS HN, HL, HP: - Thực hiện thêm chính kính - Đo nhãn áp mắt (đối với NB $\geq$ 40 tuổi)

Trình tự	Người thực hiện	Người phối hợp	Chi tiết công việc	Ghi chú
			- Không kính - Kính lõ - Kính cũ (nếu có) 3. Đo nhãn áp hơi (trừ trường hợp NB bị viêm nhiễm và trẻ em dưới 15 tuổi) 4. Nhập toàn bộ kết quả lên phần mềm và in kết quả Hướng dẫn NB đến phòng có ghi trên phiếu khám	
Bước 5 Khám	Bác sĩ chuyên khoa	Điều dưỡng phòng khám	NB cầm phiếu khám (<i>trong đó có hướng dẫn đi đến phòng khám</i>), thực hiện check-in, nhận STT, chờ trước cửa phòng, theo dõi STT hiển thị trước màn hình, đến lượt vào phòng Khi đến lượt, bệnh nhân sẽ được mời vào gặp bác sĩ. Bác sĩ chuyên khoa mắt sẽ thực hiện khám chi tiết: - Hỏi bệnh - Khám sinh hiển vi - Soi đáy mắt - Chỉ định chỉnh kính (nếu có), điều dưỡng/KTV nhập số liệu cấp đơn kính - Tư vấn, GDSK, ghi nhận thông tin về tình trạng người bệnh trên phần mềm về tình trạng bệnh, chẩn đoán, kê đơn thuốc, chỉ định điều trị ĐD hỗ trợ BS giải đáp những thắc mắc liên quan đến KCB, hướng dẫn sử dụng thuốc và chăm sóc mắt... cho NB trong phạm vi chuyên môn cho phép	CS HCM: Chỉnh kính CS Nga tự chỉnh kính – nếu có, BS Nga tự nhập KQ vào phần mềm trên form của BS
Bước 6 Chỉ định CLS	Bác sĩ tại phòng khám	Điều dưỡng/KTV khoa khám bệnh	- NB được chỉ định thực hiện CLS: xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng,... để trợ giúp chẩn đoán xác định: + In phiếu chỉ định (trong phiếu có hướng dẫn phòng cần đến) -> NB nộp phí -> checkin (tại phòng có trong phiếu hướng dẫn) -> nhận STT-> chờ đến lượt -> thực hiện chỉ định CLS -> -> điều dưỡng/KTV	Gói chỉ định CLS theo gói khám

Trình tự	Người thực hiện	Người phối hợp	Chi tiết công việc	Ghi chú
			Đẩy hình ảnh lên Forum hoặc Pacs => NB quay trở lại phòng khám ban đầu (vào phòng ưu tiên theo sự điều phối của điều dưỡng)	
Bước 7 Đọc kết quả CLS	Bác sĩ/ phiên dịch tại phòng khám	Điều dưỡng phòng khám	- NB chờ đến lượt vào phòng khám theo sự điều phối của điều dưỡng - BS người Việt sẽ đọc và trả kết quả trên forum và Pacs, ký số trả kết quả - BS người Nga đọc và trả kết quả trên form và pacs, phiên dịch hỗ trợ dịch trên phiếu trả kết quả. BS và phiên dịch cùng ký trên phiếu trả kết quả CDHA. Phiên dịch ký trước bằng chữ ký điện tử, BS ký sau và ký số.	
Bước 8 Hướng xử trí	Bác sĩ chuyên khoa	Điều dưỡng phòng khám	1. Các hướng xử trí: - Chỉ định thêm CLS: Thực hiện tương tự như bước 6 - Chỉ định thủ thuật (tiểu phẫu): + In phiếu chỉ định (trong phiếu có hướng dẫn phòng cần đến) -> NB nộp phí KHÔNG THU PHÍ: chỉ định chỉnh kính/những cận lâm sàng thực hiện lặp lại theo yêu cầu của bác sĩ : in phiếu chỉ định (trong phiếu có hướng dẫn phòng cần đến) -> thu phí (giảm trừ 100%) -> checkin (tại phòng có trong phiếu hướng dẫn) -> nhận STT -> chờ đến lượt (vào phòng ưu tiên theo sự điều phối của điều dưỡng)-> thực hiện-> phòng khám ban đầu (vào phòng ưu tiên theo sự điều phối của điều dưỡng) - NB có chỉ định tiêm => chuyển phòng Marketing/CSKH 2. Kê đơn	
Bước 9 Thực hiện thủ thuật (nếu có)	Điều dưỡng		1. NB Checkin (tại phòng có trong phiếu hướng dẫn) -> nhận STT -> chờ đến lượt 2. Mời người bệnh vào thực hiện theo STT 3. DD. Giải thích hướng dẫn người bệnh phối hợp - Thực hiện theo chỉ định	

Trình tự	Người thực hiện	Người phối hợp	Chi tiết công việc	Ghi chú
			- Trả kết quả trên PM - Hướng dẫn BN quay trở lại phòng khám để phòng khám	
Bước 10 Tư vấn	Marketing/ CSKH		Tư vấn chi phí thuốc tiêm, NB đồng ý tiêm => hướng dẫn NB quay lại phòng khám Nếu bệnh nhân không tiêm trong ngày hướng dẫn BN đặt cọc, NB nhận đơn thuốc tại phòng khám. Quy trình chuyển sang bước 14.	
Bước 11 Chỉ định tiêm	Bác sĩ		Chỉ định thuốc tiêm	CS HN, HL, HP: NB phải được hội chẩn trước khi chỉ định tiêm. Ban giám đốc quyết định mất tiêm nội nhãn, thuốc tiêm
Bước 12 Thu phí	Thu ngân		- Thu phí đối với trường hợp tiêm trong ngày - Thu đặt cọc đối với trường hợp không tiêm trong ngày - Chuyển cọc sang thu phí đối với trường hợp đến tiêm theo hẹn	
Bước 13 Chuẩn bị trước tiêm	Bác sĩ	Điều dưỡng + Khoa Dược	- Lập HS bệnh án ngoại trú - Chỉ định thuốc trước tiêm - Hướng dẫn và cho bệnh nhân ký cam kết Điều dưỡng gửi thông tin thuốc tiêm cho khoa Dược để chuẩn bị thuốc Sau khi hoàn tất thủ tục, bàn giao NB đến khoa thực hiện điều trị nội trú để thực hiện tiêm theo chỉ định	
Bước 14 Thực hiện tiêm thuốc (thực hiện tại khoa có	Bác sĩ	Điều dưỡng / Hộ lý	* Điều dưỡng - Chuẩn bị NB trước khi làm thủ thuật - Thực hiện thuốc theo y lệnh - Nhận thuốc tiêm từ Khoa Dược: kiểm tra đúng thuốc, số lượng... ký nhận - Hoàn tất những phiếu liên quan phát sinh trong quá trình NB ở tại khoa - Trả hồ sơ bệnh án được về Khoa Khám	Cơ sở HCM:

Trình tự	Người thực hiện	Người phối hợp	Chi tiết công việc	Ghi chú
điều trị nội trú)			bệnh để tổng hợp, kiểm tra, cập nhật thông tin * Bác sĩ - Lập phiếu thủ thuật	Sau khi tiêm Điều dưỡng / Hộ lý hướng dẫn NB đến phòng thực hiện đo nhãn áp và quay về phòng khám ban đầu
Bước 13 Khám, kê đơn và hướng dẫn sau tiêm	Bác sĩ	Điều dưỡng	NB quay về phòng khám ban đầu BS thực hiện kê đơn và hẹn lịch tái khám Hướng dẫn NB ra về và những lưu ý sau tiêm	
Bước 14 Đóng phí đơn thuốc, Nhận thuốc	Thu ngân Kế toán BHYT		1. Đối với NB không sử dụng BHYT - Được duyệt đơn thuốc, đến nhà thuốc bệnh viện xác nhận thuốc cần mua - Thanh toán chi phí các loại thuốc được bác sĩ kê trong đơn thuốc (L1) - Nhận thuốc tại nhà thuốc (Dược sĩ sẽ hướng dẫn cách sử dụng thuốc chi tiết, liều lượng, thời gian sử dụng, cách dùng, lưu ý khi dùng thuốc, tác dụng phụ, tương tác thuốc, và các điều kiện đặc biệt cần tránh khi dùng thuốc.) 2. Đối với NB có sử dụng BHYT: - Được duyệt đơn thuốc, NB ký bảng kê chi phí tại khu vực kế toán BHYT (L3), KT BHYT giữ bảng kê chi phí (1 bảng) - Thu ngân thu chênh chi phí (nếu có) - Lĩnh thuốc BHYT tại nhà thuốc bệnh viện. Dược giữ 1 đơn thuốc (có đóng dấu đã thanh toán BHYT)	Cơ sở HL, HP: Hoàn lại tiền BHYT thanh toán cho người bệnh
Bước 15 Kết thúc tiêm			KẾT THÚC QUY TRÌNH – LƯU HỒ SƠ Khoa Khám bệnh kết thúc HSBA ngoại trú khi kết thúc đợt điều trị (có thể từ 1-n mũi tiêm)	

Lưu ý:

1. Phát sinh mã QR động, NB có thể nộp phí ở bất kỳ đâu không cần đến quầy thu ngân
2. CS HCM: Thu chênh đối với toàn bộ NB đăng ký khám BHYT ở các bước có thu phí
3. Khi xác nhận đã thu phí, tên NB mới thể hiện tại phòng có chỉ định để thực hiện trả kết quả
4. Trường hợp bệnh nhân đang trong liệu trình tiêm nội nhãn, nhưng không tiếp tục theo hẹn và tự ý bỏ dở tại bất kỳ mũi tiêm nào (ví dụ: mũi 1, 2, 4, 5...), nếu quá 03 tháng kể từ ngày thực hiện mũi tiêm cuối mà không quay lại tái khám/tiêm tiếp, hồ sơ được kết thúc. Nhân viên phụ trách cập nhật trạng thái 'Kết thúc hồ sơ' trên hệ thống HIS, ghi rõ lý do: Bệnh nhân tự ý kết thúc liệu trình tại mũi số __, không tái khám quá 03 tháng, lưu toàn bộ kết quả điều trị đã thực hiện và thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy định."

